EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 66566
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-06-27 13:58:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PEDRO PABLO ORELLANA ORELLANA			RUN	: 6.034.959-2
F.Nac	: 29-06-1948	Edad	: 74 AÑOS, 11 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BULI ORIENTE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 950406687		
Fecha Ingreso	: 23-06-2023	Fecha Egreso	: 2023-06-27 13:58:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
VS PROSTATITIS AGUDA
HPB, USUARIO SONDA FOLEY
HEMATURIA RESUELTA
LOS ANTECEDENTES

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. M15-M19-ARTROSIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON ANTECEDENTE DE ARTROSIS, ARTRITIS, USUARIO DE CUP, INSTITUCIONALIZADO.// ALERGIA: NO TRAÍDO POR CUADRO DE VÓMITOS Y RECHAZO ALIMENTARIO.
PACIENTE A LA ANAMNESIS SE ENCUENTRA SOLO, REFIERE ORINAS MUY CONCENTRADAS Y FILTRACIÓN DE SONDA.
EX: CREA 2,30, LDH 189, LACTAO 2,2, PCR 30,1, NA 132, K 6,60, HB 8,6, LEU 17,60, INR 1,26, PSA 253,000, PROCALCITONINA 0,27.
PIELOTAC: DISMINUCIÓN DE TAMAÑO Y ADELGAZAMIENTO CORTICAL RENAL BILATERAL. QUISTES RENALES BILATERALES. AUMENTO DE VOLUMEN PROSTÁTICO. ATEROMATOSIS CÁLCICA.
CONTROL DE ELP: CREA 2,10, NA 133, K 5,5, PH 7,37.
SE DECIDE HOSPITALIZAR PARA MANEJO ATB E HIDRATACIÓN.
AFEBRIL, LÚCIDO, PIEL Y MUCOSAS DESHIDRATADAS/ CARDIOPULMONAR N/ ABDOMEN CON RHA +, BLANDO, DOLOR EN HIPOGASTRIO, PP -
ORINAS COLÚRICAS CON SEDIMENTO EN BOLSA
REFIERE AUSENCIA DE DEPOSICIONES, POR LO QUE SE EVALUA POR CIRUGIA, CON RX Y CLINICA NEGATIVA PARA OBSTRUCCION INTESTINAL
PRESENTA HEMATURIA, LA QUE CEDE CON IRRIGACION VESICAL EN 48 HRAS (USUARIO SONDA FOLEY)
SE AJUSTA TTO ATB INICIAL DE CEFTRIAXONA A CIPROFLOXACINO, HOY 2DO DIA
TIENE SOLICITUD DE ECO PROSTATICA, LA QUE SE PODRIA REALIZAR DE MANERA AMBULATORIA, PARA LUEGO REALIZAR SIC A UROLOGIA
PACTE EN BCG, ANIMO OK, CLOTE, PARAMETROS INFLAMATORIOS A LA BAJA Y MEJORIA DE FUNCION RENAL.
EN SUMA PACTE MEJOR, PUEDE CONTINUAR TTO ATB VO EN HOSPITALIZACION DOMICILIARIA Y QUEDA A LA ESPERA DE ECO VESICO-PROSTATICA

PLAN DE MANEJO:

CONTINUAR TTO ATB VO EN HOSPITALIZACION DOMICILIARIA Y QUEDA A LA ESPERA DE ECO VESICO-PROSTATICA. LUEGO DE ELLO HACER SIC A UROLOGIA

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO ASISTIDO
2. REGIMEN LIVIANO A TOLERANCIA + AGUA 1, 5 LTS POR DIA

3. CSV CADA 8HRS + HGT SOS
4. CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 5 dias via ORAL
5. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 10 dias via ORAL
6. METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 3 dias via ORAL, SOS SI NAUSEAS O VOMITOS
7. LACTULOSA SOLUCIÓN 65% FRASCO 200 MINILITROS 10 ML cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL
8. TAMSULOSINA COMPRIMIDO 0,4 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 20 dias via ORAL
9. SE DEJA ORDEN DE ECO PROSTÁTICA, A LA ESPERA DE HORA (AMBULATORIA)

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO